



**MANEJO DA
DOR CRÔNICA
NA APS**

Sinais de alarme na dor crônica: o que são e o que fazer?

Vamos juntos aprender a reconhecer situações
que exigem atenção máxima!



Baixe e imprima este
material em formato A4.



Quando se avalia uma pessoa com dor crônica na Atenção Primária à Saúde (APS), é fundamental saber identificar sinais que indicam possíveis causas graves para essa dor. Estes são chamados de sinais de alarme. Reconhecê-los é essencial para garantir a segurança do usuário e evitar atrasos no diagnóstico e tratamento de condições graves, pois podem apontar para condições que exigem investigação rápida e, às vezes, encaminhamento urgente.

O que são sinais de alarme?

Sinais de alarme (ou sinais de alerta), também conhecidos como "bandeiras vermelhas" (*red flags*), são indícios clínicos que sugerem que a dor pode estar relacionada a doenças graves ou a alterações importantes no organismo. Esses sinais servem para orientar profissionais de saúde a agir de forma mais rápida e segura.

Por que reconhecê-los é tão importante?



A identificação precoce dos sinais de alarme é crucial para:

Excluir causas graves:

garantir que a dor não é causada por câncer, infecções, fraturas, doenças neurológicas ou outras condições que necessitam de tratamento específico e urgente.

Evitar atrasos no diagnóstico:

quanto mais cedo a causa da dor for identificada, mais rápido a pessoa poderá receber o tratamento adequado.

Melhorar o prognóstico:

em muitas condições graves, o diagnóstico e tratamento precoces podem fazer toda a diferença no resultado final.

Tranquilizar a pessoa atendida:

excluir causas graves pode aliviar a ansiedade e o medo da pessoa, permitindo que ela se concentre em estratégias de manejo da dor a longo prazo.



Importância dos sinais de alarme no manejo da dor crônica



Quais são os principais sinais de alarme?

Os sinais de alarme podem ser divididos em diversas categorias, cada uma sugerindo diferentes tipos de condições subjacentes (Correia; Duncan, 2022).

É importante lembrar que a presença de um ou mais desses sinais não significa necessariamente que a pessoa tem uma doença grave, mas sim que a investigação deve ser mais aprofundada.



1. Sinais Constitucionais

Febre

Sugere infecção ou inflamação sistêmica.

Ex.: febre recorrente sem explicação.

Perda de peso inexplicada

Pode indicar câncer, infecção crônica ou doença inflamatória.

Ex.: perda perceptível de peso sem dieta ou mudança de hábitos.

Sudorese noturna

Também pode estar associada a infecções, câncer ou doenças reumáticas.

Ex.: acordar com o pijama ou lençol molhado de suor.

Fadiga intensa

Pode ser um sintoma de diversas condições, incluindo câncer, doenças autoimunes e infecções crônicas.

Ex.: cansaço frequente, mesmo após repouso adequado.



2. Sinais Neurológicos

Perda de força muscular

Sugere compressão nervosa, lesão medular ou doença neurológica.

Ex.: perder força em um braço ou em uma perna de forma repentina ou progressiva.

Alteração da sensibilidade

Formigamento, dormência, queimação ou dor em choque podem indicar neuropatia ou compressão nervosa.

Ex.: dormência, formigamento, queimação ou sensação de choque.

Incontinência urinária ou fecal

Pode ser um sinal de compressão da medula espinhal ou lesão nervosa.

Ex.: perda involuntária de urina ou fezes.

Déficits neurológicos progressivos

Piora gradual da força, sensibilidade ou reflexos pode indicar doença neurológica progressiva.

Ex.: piora gradual da força, sensibilidade ou reflexos.



3. Sinais Musculoesqueléticos

Dor noturna intensa que não alivia com repouso
Pode indicar câncer ósseo ou infecção.

Ex.: dor que acorda a pessoa do sono e não melhora com mudanças de posição.

Dor que piora progressivamente, sem melhora com tratamento
Sugere causas graves, como tumores ou infecções.

Ex.: dor que só piora, mesmo com tratamento.

Deformidades ósseas
Podem indicar fraturas, tumores ou doenças ósseas.

Ex.: perceber um “caroço” ou mudança no formato dos ossos.

Histórico de trauma recente
Fraturas, luxações ou lesões ligamentares podem causar dor crônica.

Ex.: dor após uma queda, acidente ou pancada.



4. Sinais Vasculares

Claudicação intermitente
Dor nas pernas que surge ao caminhar e alivia com o repouso, sugerindo doença arterial periférica.

Ex.: dor nas pernas ao andar, que melhora com repouso.

Dor torácica
Pode indicar angina ou infarto agudo do miocárdio, especialmente se associada à falta de ar, sudorese ou náuseas.

Ex.: dor acompanhada de falta de ar, suor ou náuseas.

Pulsos ausentes ou diminuídos
Sugere obstrução arterial.

Ex.: dificuldade para sentir os batimentos do pulso em um dos membros.



5. Sinais Reumatológicos

Rigidez matinal prolongada (> 1 hora)
Rigidez nas articulações que dura mais de uma hora pela manhã pode indicar artrite inflamatória.

Ex.: demorar muito tempo para “destravar” as articulações ao acordar.

Inchaço articular
Sugere inflamação nas articulações.

Ex.: dedo, punho ou joelho visivelmente inchados.

Erupções cutâneas
Podem estar associadas a doenças autoimunes.

Ex.: aparecimento de manchas ou lesões na pele junto com dor nas articulações.



Sinais de alarme e possíveis condições subjacentes



1. Sinais Constitucionais

- Febre
- Perda de peso
- Sudorese noturna
- Fadiga intensa



2. Sinais Neurológicos

- Perda de força muscular
- Alteração da sensibilidade
- Incontinência
- Déficits progressivos



3. Sinais Musculoesqueléticos

- Dor noturna
- Dor progressiva
- Deformidades ósseas
- Histórico de trauma



4. Sinais Vasculares

- Claudicação intermitente
- Dor torácica
- Pulsos ausentes



5. Sinais Reumatológicos

- Rigidez matinal
- Inchaço articular
- Erupções cutâneas



O que fazer diante de um sinal de alarme?

Ao identificar um ou mais sinais de alarme em uma pessoa com dor crônica, siga os passos abaixo.

1. Reavalie a história

Faça uma anamnese detalhada, por meio de perguntas sobre o início, evolução e fatores relacionados à dor.

2. Realize um exame físico completo

Avalie todos os sistemas do corpo – da cabeça aos pés – procurando sinais que possam indicar a causa da dor, mesmo que se mostre localizada.

3. Solicite exames complementares

Baseado na suspeita clínica, solicite exames laboratoriais (hemograma, VHS, PCR, etc.) e de imagem (radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas) para confirmar ou descartar as hipóteses diagnósticas.

4. Encaminhe ao especialista

Se houver suspeita de uma condição grave, encaminhe a pessoa ao especialista adequado (ortopedista, neurologista, reumatologista, etc.) para avaliação e tratamento.

5. Mantenha o acompanhamento

Mesmo após o encaminhamento, continue acompanhando a pessoa na APS, oferecendo suporte e garantindo a continuidade do cuidado.

Gerenciando sinais de alarme em pacientes com dor crônica





DICA IMPORTANTE!

Atenção aos detalhes que salvam vidas!

Sempre valorize a presença de sinais de alarme na avaliação da dor crônica, converse claramente com a pessoa atendida e trabalhe em equipe.



**Lembre-se:
agir rápido pode ser decisivo!**



Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/d/dor-cronica/view>. Acesso em: 1 jul. 2026.

CAUMO, W.; DUNCAN, M. S. Dor crônica e sensibilização central. In: DUNCAN, B. B. *et al.* (ed.). **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

CORREIA, M. P. V.; DUNCAN, M. S. Abordagem geral da dor. In: DUNCAN, B. B. *et al.* (ed.). **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.

Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS
Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - COPICS

Coordenação Geral:

Paulo Roberto Sousa Rocha
COPICS/DEPROS/SAPS/MS
Daniel Miele Amado
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

Equipe Técnica:

Nathalia Oliveira da Silva
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria

Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria

Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral

Julieta Carriconde Fripp
Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta

Simone da Fonseca Sanghi
Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Coordenação de Atividades e Logística de Campo:

Paulo Roberto Sousa Rocha

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Cau
Barlo Moreira (cores)

Diagramação e Design Gráfico

Danielle Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Rodrigo Macedo Pacheco